

TEMA 4.23 • DERMATOLOGÍA

Carcinomas Cutáneos

PERFIL EUNACOM 1.08.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Los **carcinomas cutáneos** son tumores malignos derivados de las células epiteliales de la epidermis. Dentro de los cánceres de piel no melanoma, los dos tipos más relevantes para el examen EUNACOM son el **Carcinoma Basocelular (CBC)** y el **Carcinoma Espinocelular (CEC)** (también llamado epidermoide).

Aunque ambos comparten el **fotodaño** (exposición a radiación UV) como principal factor etiológico, presentan comportamientos biológicos, riesgos de metástasis y manejos clínicos marcadamente distintos.

Carcinoma Basocelular (CBC)

El carcinoma basocelular es el cáncer más frecuente en el ser humano y, específicamente, el tumor maligno más común en el adulto mayor. Se origina en las células de la capa basal de la epidermis.

Clínica y Diagnóstico

El diagnóstico es fundamentalmente **clínico**, dada la alta sospecha por sus características físicas, aunque siempre debe ser confirmado mediante una **biopsia** (habitualmente punch o incisional).

- **Localización:** Se presenta casi exclusivamente en zonas **fotoexpuestas**, con predilección por el tercio superior de la cara (nariz, mejillas, frente y párpados).
- **Morfología clásica:**
 - **Borde perlado:** Es el signo más característico. Se observa un borde sobreelevado, brillante y translúcido.
 - **Telangiectasias:** Vasos sanguíneos finos y ramificados en la superficie del tumor o en la piel adyacente.
 - **Ulceración central:** A medida que crece, el centro suele deprimirse y ulcerarse (*ulcus rodens*).
- **Variantes:** Existen formas planas o superficiales que pueden ser más difíciles de diagnosticar y requieren alta sospecha clínica ante lesiones que no curan.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del CBC: El daño acumulativo por radiación ultravioleta produce mutaciones en genes supresores de tumores (como el gen PTCH). A diferencia de otros cánceres, el CBC tiene un crecimiento lento y una capacidad de metástasis prácticamente nula.

Manejo y Tratamiento

El tratamiento de elección es la **resección quirúrgica**.

- **Cirugía de Mohs:** Es la técnica de elección para zonas críticas (rostro, párpados, nariz) donde se busca preservar la mayor cantidad de tejido sano. Consiste en la exéresis del tumor con márgenes mínimos y el análisis histológico intraoperatorio inmediato. Se sigue ampliando el margen solo en las zonas donde la biopsia indica persistencia tumoral hasta lograr márgenes libres.
- **Cirugía Excisional estándar:** En zonas no críticas con márgenes de seguridad amplios.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

¡Cuidado! Aunque el carcinoma basocelular **no da metástasis**, es un cáncer localmente invasivo. Si no se trata a tiempo, puede destruir estructuras profundas como cartílago, hueso, ojos o invadir el conducto auditivo, causando una morbilidad severa.

Carcinoma Espinocelular (CEC)

El carcinoma espinocelular (o epidermoide) deriva de los queratinocitos de la epidermis. Es el segundo cáncer de piel más frecuente y es significativamente más agresivo que el basocelular.

Clínica y Diagnóstico

A diferencia del CBC, el CEC suele aparecer sobre lesiones precursoras como la **Queratosis Actínica** o la **Enfermedad de Bowen** (carcinoma in situ).

- **Localización:** Zonas fotoexpuestas, pero también puede aparecer en mucosas (labios, genitales) y cicatrices crónicas.
- **Morfología:**
 - **Placa hiperqueratósica:** Lesiones con costras gruesas, ásperas y adherentes.
 - **Eritema y ulceración:** Tiende a ulcerarse y sangrar con mayor facilidad que el CBC.
 - **Crecimiento:** Suele ser más rápido y puede presentar una base infiltrada (dura al tacto).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM: Si te describen una lesión en el **labio inferior** o en la **oreja** de un paciente con mucho daño solar, piensa siempre en **Carcinoma Espinocelular**.

Manejo y Pronóstico

El CEC **sí tiene capacidad de dar metástasis** (principalmente vía linfática a ganglios regionales).

- **Tratamiento curativo:** La cirugía excisional con márgenes de seguridad es el pilar del tratamiento.
- **Cáncer de bajo riesgo:** Cirugía suele ser suficiente.
- **Cáncer de alto riesgo / Avanzado:** Requiere un manejo multidisciplinario que puede incluir:
 - Disección ganglionar (si hay sospecha de compromiso linfático).
 - Radioterapia adyuvante.
 - Quimioterapia o inmunoterapia moderna en casos metastásicos.

Comparativa: CBC vs. CEC

TABLA 4.23.1: CARACTERÍSTICA VS CARCINOMA BASOCELULAR (CBC)		
CARACTERÍSTICA	CARCINOMA BASOCELULAR (CBC)	CARCINOMA ESPINOCELULAR (CEC)
Frecuencia	El más frecuente (1°)	Segundo más frecuente (2°)
Lesión Precursora	No suele tener	Queratosis Actínica , Enf. de Bowen
Apariencia Típica	Borde perlado, telangiectasias	Placa queratósica, costrosa
Metástasis	Excepcional (Casi 0%)	Posible (Linfática)
Agresividad	Localmente invasivo	Local y sistémica
Ubicación común	Cara (Nariz, párpados)	Cara, orejas, labio inferior, manos

Perlas Clínicas para el EUNACOM

- **Biopsia:** Ante cualquier lesión sospechosa que crece, cambia de color, sangra o no cicatriza en 3-4 semanas, la conducta es la biopsia.
- **Técnica de Mohs:** Clave para tumores en la cara donde se requiere ahorro de tejido y control estricto de márgenes.
- **Prevención:** El pilar fundamental es la fotoprotección desde la infancia, ya que el daño solar es acumulativo.
- **Diferenciación visual:** El CBC se ve "brillante/perlado", el CEC se ve "escamoso/queratósico".

- **Siguiente paso:** Si se sospecha melanoma, la conducta cambia (ver **Melanoma**), pero para los carcinomas no melanoma, la resección quirúrgica suele ser el primer paso terapéutico tras la confirmación.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Recuerda que el **Carcinoma Espinocelular** es el que típicamente se asocia a la transformación de úlceras crónicas o cicatrices de quemaduras antiguas (Úlcera de Marjolin).

Resumen de Manejo

- **Sospecha Clínica:** Lesión fotoexpuesta persistente.
- **Confirmación:** Biopsia cutánea.
- **Tratamiento:**
 - Quirúrgico (Exéresis simple o Mohs) en la mayoría de los casos.
 - Derivación a dermatología/oncología si hay signos de alto riesgo o sospecha de metástasis (en el caso del CEC).
- **Seguimiento:** Control periódico para detectar nuevas lesiones, dado que el paciente ya demostró tener fotodaño severo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"¿Cuál es la diferencia más importante entre el carcinoma basocelular y el espinocelular?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Carcinomas Cutáneos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El carcinoma basocelular es el tumor maligno de piel más frecuente y se localiza en la cara.
- El carcinoma basocelular tiene borde perlado, ulceración central y telangiectasias características.
- El carcinoma basocelular NO metastatiza pero sí puede invadir localmente estructuras vecinas.
- El tratamiento del carcinoma basocelular es la cirugía de Mohs con control de márgenes.
- El carcinoma espinocelular Sí puede metastatizar a ganglios y a distancia, a diferencia del basocelular.
- El carcinoma espinocelular puede originarse sobre queratosis actínicas o enfermedad de Bowen.
- El tratamiento del carcinoma espinocelular es cirugía excisional más quimioterapia en casos avanzados.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CARCINOMAS CUTÁNEOS)**PREGUNTA 1**

¿Cuál es la diferencia más importante entre el carcinoma basocelular y el espinocelular?

- A)** El basocelular es más agresivo que el espinocelular y tiene mayor tasa de recurrencia
- B)** El basocelular no metastatiza mientras que el espinocelular sí puede metastatizar
- C)** El basocelular afecta tronco y el espinocelular solo afecta cara y extremidades
- D)** El basocelular requiere radioterapia y el espinocelular solo requiere cirugía
- E)** El basocelular se origina en melanocitos y el espinocelular en queratinocitos

PREGUNTA 2

¿Cuál es el aspecto clínico característico del carcinoma basocelular?

- A)** Placa hiperqueratósica ulcerada con componente hemorrágico y bordes irregulares
- B)** Nódulo con borde perlado nacarado, ulceración central y telangiectasias superficiales
- C)** Mácula amelanótica sin borde perlado con crecimiento horizontal rápido
- D)** Pápula eritematosa con descamación y prurito intenso en zona seborreica
- E)** Ampolla tensa con contenido seroso y signo de Nikolsky negativo perilesional

PREGUNTA 3

¿Cuál es el tratamiento de elección para el carcinoma basocelular?

- A)** Radioterapia superficial con dosis fraccionadas para lesiones faciales
- B)** Cirugía de Mohs con control de márgenes en tiempo real intraoperatorio
- C)** Crioterapia con nitrógeno líquido para lesiones menores de un centímetro
- D)** Fluorouracilo tópico al cinco por ciento como tratamiento no invasivo
- E)** Quimioterapia sistémica con cisplatino para lesiones de alto riesgo histológico

RESUMEN: CARCINOMAS CUTÁNEOS

Los carcinomas cutáneos incluyen dos tipos principales. El carcinoma basocelular es el tumor maligno de piel más frecuente. Es causado por el fotodaño acumulativo y se localiza preferentemente en la cara, especialmente en la nariz. Su aspecto clínico característico es una lesión con borde perlado nacarado, ulceración central y telangiectasias superficiales. Una característica fundamental es que el carcinoma basocelular no metastatiza, pero sí puede invadir localmente estructuras adyacentes de forma agresiva. El tratamiento de elección es la cirugía de Mohs, que es una técnica de extirpación con control de márgenes en tiempo real. El carcinoma espinocelular o carcinoma de células escamosas también es causado por fotodaño y puede originarse sobre lesiones premalignas como queratosis actínicas o enfermedad de Bowen. A diferencia del basocelular, el carcinoma espinocelular sí puede metastatizar a ganglios linfáticos regionales y a distancia. Se presenta como una placa hiperqueratósica ulcerada con componente hemorrágico. El tratamiento es la cirugía excisional, más quimioterapia y radioterapia en casos avanzados.